Processo nº 0040796-59.2024.8.17.2001

AUTOR(A): BETANIA FRANCISCA MACIEL DE ALBUQUERQUE

RÉU: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de ação sob o procedimento comum ajuizada por e **BETANIA FRANCISCA MACIEL DE ALBUQUERQUE**, neste ato representada por seu filho EVERTON FRANCISCO DOS SANTOS, através de advogado (procuração de ID 167476348), em face da **HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA**, com pedido de antecipação de tutela de urgência para que a ré "*conceda autorização expressa para o internamento da autora, determinando a realização de qualquer tratamento para enfermidade que acomete a autora, bem como, qualquer medida indispensável à manutenção da saúde da autora, de acordo com a cobertura do seu tipo de plano e dispor de toda a assistência necessária à demandante, de acordo com a Lei 9.656/98 e nos termos do contrato avençado*".

À saída, a parte autora requereu: **(1)** o benefício da justiça gratuita, ao argumento de que é desempregada e está aguardando ser concedido o benefício da prestação continuada; e **(2)** prioridade de tramitação, com fulcro no art. 1.048, I, do CPC/2015, e art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, por ser a autora portadora de doença grave.

A demandante informou que é pessoa sequelada de AVC, portadora das doenças com CID 10: F01.0 e F07.8 (laudo médico de ID 167476364), beneficiária de plano de saúde da ré desde o dia 07/12/2023 – Plano "NP AHO IN GM ENF JN 087 - 484226190", Número do plano 3010J78762206, Registro plano ANS 484226190, Matrícula 3184848 (ID 167476362).

A inicial narrou que no dia **07/04/2024** a autora foi atendida na emergência da ré com insuficiência respiratória, e que, após ter sido feita medicação, em razão da insuficiência respiratória causada pela pneumonia, foi indicada a sua internação hospitalar (ID 167476371), ao que adveio a negativa da demandada, sob a justificativa de carência contratual (Termo de Indeferimento no ID 167476372), e afirmou que a qualquer momento a paciente será transferida para um hospital do Sistema Único de Saúde (SUS).

Diante do exposto, sob o argumento de que a situação da autora configura caráter de urgência, a ensejar prazo de carência de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do art. 12, V, alínea "c", c/c art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98, foi proposta a presente demanda, pugnando pela concessão liminar da tutela de urgência.

No mérito, pugnou pela confirmação da tutela e a condenação da ré em pagar indenização por danos morais no importe de R$ 14.760,00, sendo este o valor atribuído à causa.

Decisão inaugural (ID 167539797) deferiu a prioridade de tramitação e determinou a intimação da parte autora para emendar à inicial para fins de: **(a)** comprovar situação econômica condizente com a justiça gratuita; e **(b)** responder aos seguintes questionamentos: **(1)** a autora continua na emergência da Hapvida desde o dia 09/04/2024, ou teve alta (hospitalar ou médica) e, depois, voltou a ser atendida, novamente, na emergência da ré? Se foi este o caso, quando ocorreu o novo atendimento? **(2)** A autora chegou a ser transferida para algum hospital do SUS? Caso tenha sido, quando e como foi feita a sua transferência? Ela permanece internada pelo SUS? **(3)** Se a autora não estiver internada, quando ela teve alta (hospitalar ou médica)?

Em atenção ao comando judicial de ID 167539797, a autora peticionou (ID 167657560) para: **(1)** juntar a Carteira de Trabalho Digital (ID 167657562) e Extrato Previdenciário do INSS (ID 167657564), para fins de comprovar situação econômica condizente com a gratuidade judiciária; e **(2)** informar que a demandante segue internada na rede da HAPVIDA desde o dia 07/04/2024, "*entretanto os funcionários estão pressionando os familiares da autora para que ela seja transferida para a Sistema Único de Saúde (SUS)*", e que a demandada já solicitou a transferência da autora para o SUS.

Decisão de ID 167809981: (i) concede a gratuidade judiciária a parte autora; (ii) determina a intimação da operadora de saúde para falar sobre o pedido de tutela antecipada e ordena a sua citação para, querendo, ofertar contestação.

A Hapvida Assistência Médica oferta peça defensiva (ID 170126828) aduzindo, em síntese, o seguinte: (i) a operadora prestou o manejo clínico necessário ao diagnóstico do quadro de saúde da autora, não tendo restado a beneficiária desassistida em nenhum momento, em que pese não tenha cumprido o prazo de carência de 180 dias; (ii) foi admitida em leito de internamento no Hospital credenciado à demandada em data de 08/04/2024, tendo optado por dar continuidade ao tratamento, buscando a estabilização da beneficiária, onde permaneceu até a alta médica, em data de

17/04/2024, às 18h:14min, consoante resumo de alta médica; (iii) a autora encontra-se em estado geral regular, ativo e hidratado, de sorte que seu quadro clínico era de estabilidade, condição a evidenciar a ausência de urgência/emergência, permitindo a imposição do prazo carencial de 180 dias, além de sua transferência para unidade do SUS; (iv) prestou serviços com excelência para que seu quadro fosse estabilizado, com superação da situação de urgência, recebendo alta em boas condições e sem queixas; (v) a cláusula10.1 prevê período de carência de 180 dias para internação hospitalar clínica ou cirúrgica, de sorte que nos moldes da jurisprudência do STJ tal cláusula não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência; (vi) nos termos da CONSU nº 13/1998, o plano ambulatorial deverá garantir cobertura de urgência e emergência limitada até as primeiras 12 horas do atendimento, de modo que a operadora atuou em consonância com a Lei 9.656/98 e as resoluções editadas pela ANS; (vii) inexistência do dano moral em razão de não ter cometido ato ilícito, pois embora a autora não tenha preenchido o período de carência, o serviço foi prestado até alta hospitalar.

Pugna, ao final, pela improcedência dos pedidos autorais, já que não restou caracterizada falha ou má-prestação dos serviços disponibilizados.

A parte autora, em que pese devidamente intimada, não oferta réplica, conforme se depreende da certidão de ID 177249481.

A Hapvida informa não ter mais provas a produzir (ID 174319710), assim como a parte autora (ID 176357979).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Passo a analisar e decidir.

Verifico que o presente feito comporta julgamento antecipado da lide, pois não há necessidade de produção de prova, uma vez que sopesando os termos do contraditório e os elementos probatórios contidos no processo, entendo-o suficientemente instruído e, pois, maduro para ser julgado quanto a seu mérito, nos moldes do art.355, I, do CPC/2015. Acrescente-se, no ponto, que as partes também não postularam pela produção de outras provas, quando instadas para tanto.

Por oportuno, cumpre destacar que os contratos de seguro, por definição legal, encerram relação de consumo, portanto devem ser interpretados sob a ótica da legislação que lhe é própria, ainda que definidos ou regulamentados em textos outros.

Tal entendimento foi ratificado pelo STJ através do enunciado da **Súmula 608**: "*Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão*" (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).

Nas relações de consumo, notadamente aquelas que se firmam mediante simples adesão de uma parte ao contrato previamente estabelecido pela outra, devem preponderar, sobre a letra fria do texto, a boa-fé dos contratantes e o

equilíbrio contratual, ressaltando-se que a finalidade precípua do contrato de assistência médica entabulado com a ré é a manutenção da saúde da contratante, sendo responsáveis pelo fornecimento do serviço contratado todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento.

Registre-se, por oportuno, que a tutela antecipada e a própria obrigação de fazer perseguida na demanda, no que tange a obrigação de fazer – autorizar e custear o internamento hospitalar da autora junto a hospital credenciado – perdeu o objeto, tendo em vista que a autora restou atendida na rede credenciada da operadora de saúde, até sua alta hospitalar, que se verificou em data de 17/04/2024, às 18h:14min, consoante se depreende do Resumo de alta acostado no ID 170128686, que não foi impugnado pela parte autora, tratando-se, assim, de fato incontroverso.

Diante do quadro descortinado, evidencia-se situação de perda superveniente do interesse de agir relativamente à obrigação de fazer, de modo que a pretensão restante centra-se exclusivamente no invocado **dano moral,** em razão da injusta/indevida recusa de cobertura securitária.

No entanto, para apreciar a existência do invocado dano extrapatrimonial, necessário se faz analisar a conduta da operadora de saúde, a fim de identificar se foi ou não correta a sua recusa, alicerçada na assertiva de não preenchimento do prazo carencial de 180 dias para internação, aliado ao fato de que efetivamente prestou o serviço à beneficiária do plano de saúde, até a sua alta hospitalar.

A situação do caso concreto em epígrafe traz nuances e particularidades, porquanto a operadora de saúde, em que pese asseverar a existência contratual do prazo de carência de 180 dias para internação, prestou efetivamente o serviço, ao longo de 9 (nove) dias, porquanto houve a internação em data de 08/04 e a alta em 17/04/2024. Deste modo, a autora restou assistida, sem que tenha sofrido solução de continuidade do seu atendimento e internamento na própria rede credenciada, independente da intervenção judicial, já que não houve a concessão da tutela.

Enfim, não se aperfeiçoou na prática a negativa de cobertura, pois houve a prestação do serviço, com manutenção da internação da autora no nosocômio, não havendo que se falar, diante deste contexto, em aflição ou agravamento de situação psicológica, não se caracterizando, na espécie, o dano moral indenizável.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta:

(1) **Extingo o processo sem apreciação meritória,** quanto ao pedido de **obrigação de fazer**, ante a perda superveniente do interesse de agir com relação ao mesmo, na medida em que a autora foi atendida no hospital credenciado da operadora de saúde, até alta médica, verificada em 17/04/2024;

(2) **JULGO IMPROCEDENTE** o pedido de indenização por **danos morais.**

Extingo o processo com resolução do mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC/2015, com relação ao pedido de danos morais.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC, restando suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade judiciária.

Após o trânsito em julgado, se nada for requerido, proceda-se ao arquivamento dos autos.

P.R.I

Recife, 27 de agosto de 2024.
Virgínia Gondim Dantas

Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: VIRGINIA GONDIM DANTAS
27/08/2024 09:48:15
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 180199494

24082709481513200000175827180

IMPRIMIR GERAR PDF